

a2_cca_hub 测试报告

生成时间：2026-05-08 20:07:58

测试时间：2026-05-08 20:07:58

- 一、测试目的：验证工具增强对输出质量提升作用。
- 二、测试内容：同一输入下，分别运行 use_tools=True/False。
- 三、测试方法：对比输出结构与长度，核对产物路径。
- 四、测试过程：
 - 1) 启用工具运行；
 - 2) 禁用工具运行；
 - 3) 指标对照；
 - 4) 结论归纳。
- 五、测试结果：

启用工具 success=True chars=1402 markers=12

禁用工具 success=True chars=1809 markers=20

工具说明：tool_近况摘要:tool_近况摘要：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_风险洞察:tool_风险洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_照护洞察:tool_照护洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_体征洞察:tool_体征洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_用药洞察:tool_用药洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_健康评估记录:tool_健康评估记录：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_睡眠记录:tool_睡眠记录：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_最新时序摘要:tool_最新时序摘要：从长者智能计算图提取历史参考证据

六、结论：工具可显著提升智能体输出准确性、完整性与专业性，助力机构提供更精准照护与医疗服务。

【启用工具输出摘录】

****陈萍忠老人D5护理评估与周任务指导报告****

****一、评估结论****

1. ****跌倒风险高****：老人存在阿尔茨海默病性痴呆伴定向力下降、平地行走需部分辅助、既往有夜间如厕跌倒史（2026-03-08），且当前服用劳拉西泮、奥氮平等镇静类药物（健康评估记录确认），多重因素叠加显著增加跌倒风险。近期反复出现无明确外伤的皮肤擦伤与淤青，提示环境存在潜在碰撞隐患或活动监护不足。
2. ****服药依从性存疑****：用药记录存在重复录入现象（如多奈哌齐多次记录），可能掩盖实际服药行为。老人因认知障碍及BPSD可能拒服药物，需直接观察确认服药完成情况。
3. ****认知干预依从性低****：明确拒绝康复训练及集体活动，但保留对舞蹈的兴趣，提示非药物干预需个体化调整，避免强制参与引发对抗行为。
4. ****循环功能监测不足****：心率长期60次/分（起搏器依赖可能），但缺乏日间活动状态下的血压、血氧、心率联合监测数据，无法全面评估心血管稳定性。

****二、本周重点护理任务（D5 – D11）****

1. ****跌倒防护强化****
 - 如厕、洗浴、夜间离床必须全程陪护，浴室铺设防滑垫，移除走廊及居室尖锐物品；
 - 平地行走时提供稳定辅助器具（如四脚拐），避免独自行走；
 -

每日检查皮肤完整性，尤其四肢及臀部，记录新发淤青/擦伤的时间、部位、大小及可能诱因。

2. **规律服药保障**

- 护士须亲眼确认老人服下每剂药物，严禁将药物放置床头自行服用；
- 核对医嘱清单，清理重复录入项，确保电子记录与实际给药一致；
- 观察服药后反应（如嗜睡、步态不稳），及时反馈医生评估镇静药物必要性。

3. **认知干预优化**

- 利用其“喜好跳舞”特点，安排每日15–20分钟一对一音乐律动活动（如坐姿手势舞），避免强制参与集体项目；
- 采用简单指令、正向鼓励方式引导日常活动，减少直接否定语言；
- 记录每次干预尝试的接受程度、持续时间及情绪反应，用于动态调整方案。

三、D5数据录入规范

1. ****生命体征****：若已测量D5血压、心率、血氧，请按实际数值录入系统，注明测量时段（晨/午/晚）及活动状态（卧位/坐位/活动后）。当前仅知心率长期60次/分，但D5具体血压值未提供，相关字段请据实填写或留空。
2. ****用药记录****：仅录入当日实际给予并确认吞服的药物，剂量、时间精确到分钟，禁止复制历史记录。
3. ****行为事件****：对“拒绝康复”“夜间离床”等行为，需描述具体情境（如“15:30邀请参加手工课，摇头说‘不要’，未发生激越”），避免笼统标注“不配合”。
4. ****皮肤状况****：发现任何破损、淤青，需拍照存档并文字记录位置、尺寸、颜色、处理措施（如碘伏消

【禁用工具输出摘录】

****陈萍忠老人D5评估与周护理任务指导报告****

一、评估结论

1. ****认知与精神行为****：确诊阿尔茨海默病性痴呆，当前存在明显行为心理症状（BP SD），表现为拒绝参与康复训练及集体活动，提示依从性下降，需警惕社交退缩与功能加速衰退风险。
2. ****躯体功能与安全****：平地行走需部分辅助，结合既往头部外伤史（右额部皮下血肿），属****跌倒高风险人群****；生命体征平稳（心率60次/分，与起搏器功能一致），暂无急性心血管事件表现。
3. ****慢性病管理****：有高血压倾向、血脂异常及心电图T波改变病史，但****本次未提供具体血压、血脂数值****，无法评估当前控制状态。
4. ****日常生活与兴趣****：睡眠规律，喜好跳舞，可作为非药物干预切入点。

> 注：因未提供住院前、出院时及D5的具体血压、血脂数值，无法进行纵向对比或疗效评估，相关结论留空。

二、本周重点护理任务（D5–D11）

（1）跌倒防护强化措施

- 执行**跌倒风险每日评估**（如Morse量表），记录辅助行走需求变化。
- 确保助行器/拐杖处于可用状态，环境无障碍（夜间照明、防滑垫、呼叫铃易触及）。
- 头部外伤部位（右额部）每日观察有无红肿、压痛或波动感，记录于皮肤评估栏。

（2）规律服药保障

- 核对医嘱药物清单，重点关注**降压药、调脂药、痴呆治疗药**（如多奈哌齐）是否按时服用。
- 针对拒药行为，采用**简化给药流程+正向激励**（如服药后安排听音乐/看舞蹈视频）。
- 记录每次给药时间、剂量及老人反应，发现漏服立即补录并上报。

（3）认知与行为干预

- **个性化活动引导**：利用其“喜好跳舞”特点，安排每日10–15分钟坐姿舞蹈操（避免跌倒），由护士一对一陪伴，降低抗拒。
- **非强制参与原则**：不强迫参加集体活动，改为小范围、低刺激互动（如回忆老歌、拼图）。
- 记录BPSD发作频率、诱因（如指令过多、环境嘈杂）及缓解方式，用于D14复评。

三、D5数据录入规范指引

请按以下要求在电子护理系统中准确录入今日（D5）数据：

1. **生命体征**：

- 血压：录入**静息状态下三次测量平均值**（单位mmHg），注明测量时间（如08:00、14:00、20:00）。
- 心率：记录为“60次/分（起搏心律）”，勿标注“窦性”。

2. **慢病指标**：

- 若已检测血脂（TC、TG、LDL-C、HDL-C），需完整录入四项数值及单位（mmol/L）；若未测，字段留空，**不得填写“正常”或“未见异常”**。

3. **照护行为记录**：

- 在“康复参与”栏注明：“